

Logística Hospitalar

EDMUNDO SOUZA



Unidade 1

Livro Didático
Digital



Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial
ANDRÉA CÉSAR PEDROSA

Projeto Gráfico
MANUELA CÉSAR ARRUDA

Autor
EDMUNDO SOUZA

Desenvolvedor
CAIO BENTO GOMES DOS SANTOS

O AUTOR

Edmundo Souza

Olá. Meu nome é Edmundo Souza. Sou formada em Administração Hospitalar, com uma experiência técnico-profissional na área de Gestão Administrativa, Compras e Suprimentos, mais de 25 anos. Passei por empresas como a Amil, Hospital São Camilo, Grupo Hemocentro São Lucas, Hospital e Maternidade Voluntários. Como professor de cursos superiores e pós-graduação, mais de 12 anos. Passei por empresas como Anhanguera Educacional, FMU, Laureate International Universities e SENAC. Atualmente trabalho no Departamento de Compras e Suprimentos do GNDI-Grupo NotreDame Intermédica e também sou Tutor EAD da UNIP. Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Meu nome é Manuela César de Arruda. Sou a responsável pelo projeto gráfico de seu material. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



INTRODUÇÃO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;



EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;



ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;



IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;



RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Evolução do sistema hospitalar da história 11

A história da Medicina.....11

O médico não era mais importante para o Hospital.....15

A crise da Saúde pública.....16

Histórico dos modelos assistenciais no Brasil..... 19

Novos modelos assistenciais25

Sistema único de saúde28

Antecedentes do SuS: breve trajetória.....29

As origens da saúde previdenciária32

Anos 1970: expansão e crise do modelo médico-previdenciário34

Os anos 1980 e a transição para a seguridade social.....36

A institucionalização do SuS: marcos legais e históricos41

O SUS como novo pacto social.44

O SUS como novo desenho político-institucional.....45

SUS como novo modelo técnico-assistencial.....49

Os anos 1990 e a implantação do SUS: desafios e inovações51

O SUS e a NOB-96.....55

UNIDADE

01

INTRODUÇÃO

Já há algumas décadas percebemos o sentimento de que os problemas de saúde estão se acumulando, em virtude dos serviços de saúde não conseguirem atender às necessidades da sociedade nem às expectativas da população. Comprovamos isso quando avaliamos os levantamentos estatísticos nos diversos grupos populacionais, pois, ao lado da violência e do desemprego, a questão saúde sempre se destaca entre as prioritárias.

Os meios de comunicação nos mostram as limitações e as situações mais absurdas em relação ao atendimento prestado à população pelos serviços de saúde, enfatizando os dramas individuais e colocando à prova a função social dos atendimentos de saúde. Até mesmo entre os profissionais do campo da saúde pública generaliza-se a impressão de que uma crise profunda percorre a sua área de atuação, fazendo com que muitos dos conceitos e dos recursos técnicos valorizados até um momento recente pareçam, atualmente, obsoletos; disso resulta um crescente sentimento de mal-estar, o que dificulta a possibilidade de identificação das propostas alternativas capazes de recuperar a efetividade do setor.

Esse sentimento de crise parece paradoxal quando consideramos que no século XX houve muitos avanços no setor da saúde: os modelos de atenção à saúde, tanto individual quanto coletiva, apresentaram um aumento progressivo na duração média da vida; uma extensão lenta, mas contínua do acesso aos cuidados médicos e às condições de saneamento básico para muitos grupos até então excluídos; e o desenvolvimento científico e tecnológico das práticas de saúde, que possibilitaram a inclusão de avanços da engenharia genética e da informática. Entretanto, apesar de todo esse avanço, por que a descrença na saúde?

Apesar de todo esse avanço social, tecnológico e científico, constatamos que a crise na saúde se impõe. Portanto, precisamos analisar não apenas as características do modelo atual, mas a complexidade do fracasso do nosso modelo assistencialista.

Na verdade, é necessário identificar as causas de duas crises pontuais: a da saúde e a do desenvolvimento econômico e social. Por exemplo, na dimensão do financiamento, vemos que o volume e a prioridade da aplicação dos recursos públicos em saúde passaram a ser cada vez mais questionados. Tal discussão torna-se mais acirrada quando se trata de recursos destinados a assegurar a prestação de atenção médica às populações progressivamente mais idosas que, sem rendimentos e poupança privada capazes de garantir-lhe o pagamento dos novos e custosos serviços e medicamentos, estão excluídas dos processos de trabalho e carentes de procedimentos de maiores custos e complexidade tecnológica.

Porém, devemos ter claro que a crise atual da saúde não se resume apenas aos aspectos financeiros: ela se torna mais complexa ainda quanto às suas dimensões ou modos de expressão. Devemos destacar também a redução da capacidade de resolução prática que nos remete às expectativas das pessoas em relação à saúde, à questão ética do valor da vida e à dissociação entre o discurso dominante e a experiência cotidiana.

Quanto à dimensão ética, as condições em que vive grande parte das pessoas não são compatíveis com a ideia de que a vida humana seja um valor absoluto. O uso disseminado de drogas, a ampliação

da violência, a propagação de diversos estilos de vida de alto risco, a degradação do meio ambiente e a persistência da miséria apontam que o respeito à vida hoje não está colocado em primeiro plano. Outro componente é a descrença na efetividade da atenção médica. Qual a sua capacidade de contribuição para melhorar a qualidade de vida das pessoas? De quanto é o seu potencial para reduzir o sofrimento e a dor?

A tentativa de resolver diferentes problemas sociais amplia de modo injustificado a abrangência e as expectativas em relação à efetividade das ações de saúde, o que certamente contribui para exacerbar o ceticismo da população. Ao mesmo tempo, se o modelo assistencial dos sistemas públicos de saúde prioriza a extensão de cobertura e a universalização do acesso a algum tipo de cuidado, ele não assegura a solução e nem sequer a satisfação com o atendimento recebido.

A simples atenção às demandas de saúde não vem resultando na eliminação dos problemas que, ao contrário, têm se acumulado. Não há qualquer sombra de dúvida que, mesmo quando essas demandas se tornam capazes de evitar ou de retardar a morte, por exemplo, as práticas utilizadas não reduzem a morbidade na mesma proporção. Esse descompasso entre o atendimento às demandas e as suas práticas tem resultado na revalorização de práticas da medicina tradicional e nas diferentes formas de curandeirismo que, se também não curam, pelo menos atendem às necessidades essenciais de suporte psicológico e de interação comunitária, com um custo capaz acessível às pessoas e à sociedade.

A visão de mundo elaborada com base em uma perspectiva científica e materialista vem perdendo terreno para aquelas centradas em valores místicos, disseminadas por toda a sociedade, sobretudo nas periferias urbanas. Mesmo entre profissionais e pesquisadores da saúde, é surpreendente a perda de confiança no uso da racionalidade científica como método para resolução de problemas, especialmente se considerarmos os imensos e recentes avanços nas diversas áreas das ciências da vida. É preciso levar em conta, entretanto, que há uma imensa distância entre as possibilidades anunciadas pelo desenvolvimento técnico-científico e as suas práticas cotidianas, ainda respaldadas por modelos e meios limitados e simplificadores. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 1**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

- 1.** Entender a Evolução do Sistema Hospitalar na História e a crise da saúde Pública;
- 2.** Compreender os Históricos dos modelos assistenciais à saúde no Brasil e os novos Modelos Assistenciais;
- 3.** Entender sobre o Sistema Único de Saúde, sua institucionalização: marcos legais e históricos;
- 4.** Compreender os anos 1990 a implantação do SUS: Desafios e Inovações

Então? Preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento? Ao trabalho!

Evolução do Sistema Hospitalar da História



OBJETIVOS

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona os conceitos básicos da gestão hospitalar. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentaram o sucesso sem a devida instrução tiveram problemas com os seus resultados? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

A história da Medicina

Na história da medicina, encontramos os primeiros relatos da estrutura hospitalar no mundo greco-romano, onde diversos templos eram erguidos em homenagem ao Deus da medicina, que na Grécia era chamado de Asclépio, e em Roma era Esculápio.

O objetivo desses templos era o atendimento a pessoas doentes, mas eles também eram utilizados por pessoas que buscavam na prática da medicina um auxílio para um "adormecimento", como se esse sono os curasse de forma milagrosa.

Outra característica do modelo grego era ser itinerante. Os médicos andavam de porta em porta para oferecer seus serviços.

Com um aspecto também religioso, os procedimentos curativos, medicamentosos e cirúrgicos eram realizados por sacerdotes, por considerarem ter ajuda espiritual. Outra particularidade desses templos que os assemelha às nossas instituições hospitalares é a forma como os pacientes eram tratados de maneira impositiva: os sacerdotes detinham o poder de cura e os pacientes recebiam todas as intervenções de maneira passiva.

Aos poucos, os médicos gregos começaram a migrar para Roma, onde foram ganhando mais prestígio e começaram a direcionar suas ações

médicas para reabilitar pacientes pobres que estavam em “instituições”, de maneira que estes pudessem novamente trabalhar, especialmente em guerras.



Fonte: Freepik

Já no período medieval, da mesma maneira que na Grécia e em Roma, a medicina recebia forte influência religiosa, em especial nessa época devido ao cristianismo, que acreditava que aqueles que ajudavam as pessoas mais pobres e necessitadas teriam as suas almas levadas para um local mais nobre após a morte. Assim, a função da medicina era de acolher e dar assistência social.

Por suas características fortemente religiosas, as instituições eram locais não apenas onde os pacientes eram internados, mas também onde os médicos residiam. Seus gestores, nessa época, eram principalmente os padres.

No final da Idade Média, os hospitais passaram a ser de administração pública, deixando de ser exclusivamente administrados por ordens religiosas.

O hospital que funcionava na Europa desde a Idade Média não era, de modo algum, um meio de cura, não era concebido para curar.

Houve, de fato, na história dos cuidados do Ocidente, duas séries não superpostas; encontravam-se, às vezes, mas eram fundamentalmente distintas: as séries médica e hospitalar. O hospital como instituição importante e mesmo essencial para a vida urbana do Ocidente, desde a Idade Média, não é uma instituição médica, e a medicina é, nesta época, uma prática não hospitalar (FOUCAULT, 1979, p. 101 apud PEREIRA, 2003, p. 37).



ACESSE

Para aprofundar seus conhecimentos acerca do conteúdo estudado no tópico 1.1, leia o artigo História da Medicina acessando: <http://rmmg.org/artigo/detalhes/1590>

O médico não era mais importante para o Hospital

Assim, o hospital medieval europeu separava as pessoas que eram consideradas sadias daquelas que eram ditas como perigo para a sociedade. Portanto, o médico não era a figura mais importante da instituição hospitalar.

A partir do século XVI, a melhoria do bem-estar da população e das condições gerais de saúde passou a ser um objetivo a ser alcançado pelo poder governamental.

As mudanças mais significativas nas instituições hospitalares acontecem entre os séculos XVI e XIX, com o entendimento de que sua função de cura estava mais associada à prática médica, e não ao assistencialismo religioso.

Já no século XX, com o crescimento e desenvolvimento da teoria bacteriológica, é que acontece a grande mudança nessa estrutura, e o cuidado ao doente passa a ser mais sistematizado e pautado na condição de manutenção adequada do ambiente, para a redução da morbimortalidade nas instituições hospitalares.

Assim chegamos ao conceito de imprescindibilidade social das instituições hospitalares, para a manutenção do bem-estar geral da sociedade.

A crise da Saúde pública

Para iniciarmos nosso entendimento de modelos de atenção à saúde, precisamos definir o que é modelo de atenção.

Diversas ações de intervenção no processo saúde-doença e a maneira como elas são organizadas e combinadas chamam-se modelo de atenção à saúde ou modelo assistencial. De outra forma, podemos definir modelo assistencial como a forma específica de organização e de articulação entre os recursos físicos, tecnológicos e humanos para enfrentar e resolver os problemas de saúde existentes em uma coletividade.

Para a sua configuração, o modelo assistencial engloba não apenas a lógica do financiamento, mas também a natureza mais particular de suas práticas no campo de saúde.

No âmbito do financiamento, podemos observar modelos mais redistributivos, isto é, que procuram ter mais equidade, ou modelos mais excludentes, nos quais o acesso aos serviços, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, é diretamente proporcional ao quanto contribuíram financeiramente para o sistema.

Na esfera das práticas de saúde, podemos identificar alguns modelos que desenvolvem exclusivamente ações de natureza médico-curativa, pois focalizam apenas a doença, e outros modelos que incorporam tanto ações de promoção quanto de prevenção, isto é, sua atuação é anterior aos processos patogênicos.

Existem outras características que podem diferenciar os modelos de práticas de saúde. Dentre eles, podemos citar a própria organização e a harmonia entre os serviços de saúde e destes em relação aos usuários. Podemos identificar os modelos em que os seus serviços simplesmente

atendem às exigências, estando sempre “aguardando e abertos” para os casos demandados espontaneamente pelos usuários. No entanto, vemos modelos em que as ações podem ser realizadas ativamente sobre os usuários, independentemente de sua demanda. Há diversas outras variáveis ou características que diferenciam os modelos e que, em última instância, condicionam ou mesmo tomam parte da prática assistencial final.

É comum ouvirmos frases do tipo “o modelo assistencial precisa ser mudado” ou “o atual modelo não funciona, não é eficaz”. Precisamos tomar cuidado para não vulgarizarmos os debates sobre a reorganização dos serviços de saúde, por não saber justificar o termo modelo assistencial.



IMPORTANTE

Especialmente no Sistema Único de Saúde (SUS), boa parte dos problemas passou a ser atribuído ao modelo assistencial vigente e todas as esperanças passaram a se concentrar em um novo modelo assistencial. Consequentemente, isso gerou distorções na compreensão de modelos assistenciais, sobretudo no que diz respeito à pretensão de que existam modelos corretos e modelos errados. Tudo isso levou a pensar que se tratava de uma questão de fórmula, de achar a fórmula correta. É preciso saber que não existe um modelo certo ou errado. Existem, sim, modelos adequados ou não à realidade social e sanitária em que estão inseridos e os quais buscam transformar.

Assim, ao abordarmos os modelos assistenciais, estamos tratando das diversas características que condicionam uma prática assistencial, pelo menos no que se refere: ao seu financiamento, à sua organização e às suas relações com os serviços num dado sistema de saúde; aos tipos de atividades assistenciais ofertadas; às suas relações ativas ou passivas entre o sistema e os seus usuários; às barreiras e/ou às facilidades de acesso aos usuários; aos perfis dos seus profissionais e às suas funções no interior do sistema.

Devemos considerar ainda que os modelos são historicamente construídos. Os modelos respondem aos condicionamentos a que estão

expostos, sejam de ordem política, econômica, técnica ou cultural, para destacarmos talvez as principais dimensões. Por serem historicamente construídos, eles apenas existem em uma determinada realidade concreta. O próprio termo modelo é limitado, já que não existe, na prática, nenhum modelo puro.



Fonte: Freepik

Histórico dos modelos assistenciais no Brasil



OBJETIVOS

Devemos, em primeiro lugar, sistematizar de forma breve a evolução histórica dos modelos assistenciais no Brasil, tomando o século XX como período de análise.

Podemos identificar dois modelos que tiveram grande importância no enfrentamento dos problemas de saúde. São modelos moldados por lógicas totalmente distintas, por vezes até contraditórias, mas que ilustram bem a evolução do Brasil e dos modelos assistenciais de acordo com os condicionantes econômico-sociais e culturais. Trata-se do sanitarismo campanhista e do assistencialismo médico. Esses dois modelos ainda hoje têm grande importância no nosso sistema atual.

O sanitarismo campanhista encarna a saúde pública tradicional desenvolvida desde o início do século XX, visando ao combate às grandes endemias. Fundamenta-se nos conhecimentos sobre as causas e os mecanismos de transmissão das doenças infecciosas propiciados pela revolução pasteuriana. Busca ordenar uma oferta de serviços, envolvendo não só – e nem especialmente – médicos empenhados em combater as causas e interromper a transmissão das doenças na coletividade, mas também todos os outros profissionais de saúde. Isso é feito por meio de oferta, às vezes compulsória, de serviços e de ações sanitárias sobre o ambiente, os indivíduos e os vetores animais, independentemente da demanda e até mesmo da vontade das pessoas (vacina, inseticida etc.). Ele leva ao extremo a preocupação com os problemas coletivos, subestimando o cuidado individual.



SAIBA MAIS

Para a compreensão dos conceitos sobre as causas e os mecanismos de transmissão das doenças, é importante conhecer o modelo da tríade causal das doenças. Como material referencial, sugiro: Organização PAN-AMERICANA DE SAÚDE – OPAS. Módulo de princípios de epidemiologia para o controle de enfermidades (MOPECE). https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&alias=951-modulos-principios-epidemiologia-para-controle-enfermidades-mopece-modulo-3-1&category_slug=informacao-e-analise-saude-096&Itemid=965

Esse modelo desenvolveu-se com base na necessidade de saneamento dos espaços físicos e econômicos de circulação de mercadorias, nos marcos da economia agroexportadora dominante no início do século XX. Nesse período, o País precisava livrar-se dos altos índices de ocorrência da peste bubônica, da febre amarela, da malária, da varíola etc. O modelo da primeira década desse século foi formulado e praticado por meio da Reforma Sanitária de Oswaldo Cruz e até hoje influencia as estratégias de controle de endemias. É a partir da sua lógica assistencial que a saúde pública se materializa historicamente em nosso país. O Ministério da Saúde e mesmo as Secretarias de Saúde, tanto as estaduais quanto as municipais, têm suas origens influenciadas por esse modelo.

Já o modelo médico-assistencialista surgiu com a urbanização e a industrialização aceleradas que ocorreram no Brasil, nos anos de 1920-1930. A constituição de uma classe trabalhadora urbana, concentrada em termos geográficos, gerou a necessidade de se criar uma assistência médica individual que fosse capaz de satisfazer a sua reprodução física como força de trabalho.

Esse modelo desenvolveu-se a partir e no interior do sistema previdenciário (IAPs, depois INPS e Inamps), dando assistência, inicialmente, apenas às famílias e aos trabalhadores inseridos formal e reconhecidamente no mercado de trabalho. Aqui, por definição, o sistema se desenvolveu exclusivamente considerando o atendimento à demanda

definida individualmente pelos trabalhadores na sua autoavaliação de saúde (queixas pontuais). Essa lógica de atenção ajustava-se e valorizava o sistema industrial, que necessitava de trabalhadores em condições de trabalhar. Ao longo dos anos, com o predomínio crescente da indústria e das atividades urbanas na economia, esse modelo se expandiu, envolvendo mais recursos e consolidando um poderoso sistema de atendimento individual mais abrangente, complexo, caro e dominante.

Desse modo, podemos afirmar que o sistema de saúde no Brasil caracteriza-se historicamente por um dualismo marcado pela separação entre as atividades preventivas, ditas então de saúde pública, e as atividades curativas na atenção à saúde.

Tal dualismo esteve na base da própria divisão institucional de atribuições, caracterizando dois sistemas paralelos. De um lado, o Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, responsáveis pelas atividades de prevenção e promoção, incluindo os cuidados mais básicos. De outro, os institutos previdenciários por categoria profissional (Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos – IAPM, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários – IAPI etc.), unificados no Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, em 1966 e, finalmente, transformados no Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social – Inamps, responsável pelas atividades curativas, ou seja, pelas consultas, exames, hospitalizações, cirurgias etc.



A unificação dos institutos de previdência, incluídos os setores de assistência médica, permitiu consolidar na década de 1970 uma hegemonia do modelo médico-hospitalar privatista. Naquela década, sustentada por financiamentos públicos, pôde-se expandir espetacularmente uma rede privada, dependente da previdência, uma vez que a maior parte de seus serviços era contratada pelo Inamps. No mesmo período, a assistência previdenciária incorporou gradativamente novas populações: as do campo, do Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural – Funrural, foram, enfim, incluídas. O modelo médico-assistencial consolidou sua hegemonia, uma vez que não era mais restrito aos contribuintes previdenciários, na forma dos institutos do passado.

É possível constataremos que, simultaneamente ao período em que se dá a maior expansão da assistência médica curativa e a unificação dos institutos e incorporação das populações antes dependentes da saúde pública, ocorreu o início do que hoje chamamos de modelo supletivo de atenção – planos. Esse movimento pode ser diagnosticado como uma espécie de escapismo (da assistência médica previdenciária unificada) de grupos de trabalhadores e empresas mais dinâmicas, visando dar condições especiais de assistência médica e, naturalmente, manter controles mais próximos sobre tal força de trabalho.

Do mesmo modo que nas décadas anteriores as categorias mais dinâmicas da economia se organizaram em institutos, agora categorias dinâmicas e organizadas, como os bancários, também se tornam mais competitivas, inaugurando os planos de saúde. Não é por acaso que a medicina de grupo nasceu do ABC paulista. Assim como nos institutos previdenciários, os planos que se expandiram nas décadas seguintes à unificação da previdência diferenciavam clientelas e, naturalmente, serviços. Em termos análogos, respeitando-se as diferenças decorrentes dos momentos históricos, os planos e os seguros passaram a assistir às populações que antes eram atendidas pelos institutos previdenciários das categorias profissionais.

O paralelismo entre os dois modelos, além de gerar disputas por recursos, propiciou uma série de desvios. Primeiro, havia uma distribuição desigual da oferta, com a assistência médico-hospitalar concentrada

nos grandes centros, onde estava o mercado de profissionais (médicos, sobretudo), de bens (medicamentos, equipamentos médicos) e de serviços (exames laboratoriais, ambulatoriais, hospitais), deixando o interior do País e as periferias urbanas limitadas aos serviços de prevenção e assistenciais de baixa complexidade (expressos nos postos e centros de saúde).

A falta de integração entre os dois sistemas levava a um círculo vicioso. As pessoas, para resolverem os problemas ou as queixas mais simples, buscavam os hospitais, uma vez que não tinham conseguido atendimento para a solução nos postos e centros de saúde (que somente ofereciam atividades preventivas e consultas simplificadas, com baixa ou nenhuma resolutividade). Isso acontecia, sobretudo, nos casos das emergências, em que as pessoas, a qualquer hora, teriam acesso aos recursos diagnósticos e terapêuticos mais adequados, sem necessidade de marcação prévia de consulta e fila para atendimento. A sobrecarga terminou por comprometer a qualidade da atenção hospitalar, que se mantinha refém do excesso de demanda.

Resultado: nem o sistema básico ocioso conseguia dar conta satisfatoriamente da saúde coletiva, nem o sistema hospitalar, sobrecarregado e onerado, resolvia os problemas individuais com qualidade.

Resultado: nem o sistema básico ocioso conseguia dar conta satisfatoriamente da saúde coletiva, nem o sistema hospitalar, sobrecarregado e onerado, resolvia os problemas individuais com qualidade.

Quadro 1

Sanitarismo	Assistencialismo médico
Financiamento público estatal.	Financiamento misto (empregado, empregador).
Acesso universal.	Acesso à população definida.
Ações enfaticamente de prevenção.	Ações curativas.
Ações programadas.	Atendimento à demanda.
Ações sobre o ambiente e coletividade.	Ações individuais.
Práticas não necessariamente médicas.	Práticas enfaticamente médicas.
Ações não hospitalares.	Ações enfaticamente hospitalares.

Visando à superação desses modelos, foram elaboradas várias propostas críticas para a elaboração de uma reforma do sistema de saúde, a partir dos anos 1970 e, sobretudo, ao longo dos anos 1980. Essas propostas concretizaram-se, finalmente, no SUS, que apontou para a superação do modelo assistencial então vigente, dicotômico e hegemonizado pela assistênciamédica individual, em direção a um novo modelo baseado na integralidade da atenção à saúde. Nesse processo, alguns momentos foram relevantes, como a política das Ações Integradas de Saúde (AIS) e posteriormente do Sistema Unificado Descentralizado de Saúde (SUDS), precursor do SUS, instituído na Constituição de 1988.

Não é difícil compreender que o modelo médico-hospitalar-curativo é herdado e desenvolvido pela atenção supletiva. No SUS, identificamos disputas entre os modelos derivados do sanitarismo e do assistencialismo médico, uma vez que a unificação dos sistemas previdenciário e da saúde pública, consagrada na Constituição de 1988 e na Lei nº 8.080/90, colocou ambos sob a tutela das mesmas instituições: Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde. Há mesmo no âmbito do SUS novos modelos de atenção decorrentes da superação de ambos e mais próximos do paradigma sanitário.

Novos modelos assistenciais

Ao analisarmos o processo de mudança no sistema nacional de saúde, podemos identificar três espaços onde as transformações se dão: o jurídico-legal, o institucional e o operativo.

O primeiro está delimitado pelas normas jurídico-legais que não apenas regulam o funcionamento dos sistemas de saúde como também condicionam as mudanças que poderão ocorrer nos dois outros espaços. Esse aparato jurídico está representado tanto na Constituição brasileira, especialmente nos artigos que tratam da saúde, quanto nas leis e nas demais normas setoriais, como as Leis nº 8.080/90, nº 8.142/90 e nº 9.656/98.



IMPORTANTE

As Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90 são conhecidas como as Leis Orgânicas da Saúde, que regulamentaram a criação do SUS. O espaço institucional está representado pelas organizações atuantes no setor, nos níveis federal, estadual e municipal. O espaço operativo tem a ver com a realidade e a natureza das práticas de saúde. Trata-se do espaço em que um:

[...] sistema de saúde adquire concretude, mediante o estabelecimento, num território determinado, de uma relação direta e recíproca entre suas unidades produtoras de serviços, geridas por uma autoridade sanitária e uma população com suas necessidades e representações (MENDES, 1995, p. 139).

Para entender o processo de conformação e as explicações sobre os modelos assistenciais, deveremos utilizar as compreensões das dimensões que interagem na constituição de um modelo assistencial, que são no mínimo três: uma ideológica, que expressa não uma visão geral do mundo, mas sim uma visão do que seja saúde (ainda que esta guarde

relação com a visão mais geral do mundo e das sociedades); uma política, que expressa a disputa dos interesses entre os atores envolvidos na área ou em um setor; e uma dimensão técnica, que relaciona as possibilidades dadas pelo conhecimento e pelas tecnologias, a fim de viabilizar a prática.

O termo ideológico é utilizado como referência aos paradigmas assistenciais que embasam dois modelos de atenção polares: o clínico e o modelo assistencial dele derivado e baseado na doença e nos processos de trabalho médico. O contraponto desse paradigma, chamado de sanitário, reflete uma concepção ampliada do processo saúde-doença.

Sintetizando os principais elementos de ambos os paradigmas, teremos:

Paradigma clínico	Paradigma sanitário
Mecanismo: expressa essencialmente a noção do paciente como uma máquina com partes a serem separadas.	Globalidade: reconhece o sujeito da prática sanitária como uma unidade biopsicossocial inserida numa realidade histórica.
Biologismo: refere-se à noção predominante da natureza biológica das doenças.	Determinação social do processo saúde-doença: reconhece o biologismo como superado por variáveis socioeconômicas, determinantes do processo saúde-doença.
Individualismo: exclui os aspectos sociais da vida do indivíduo.	Coletivismo: resgata a natureza coletiva dos sujeitos da prática sanitária, sem implicar o desconhecimento de suas dimensões individuais.

Especialismo: aprofunda o conhecimento em detrimento da globalidade de seu objeto.	Equilíbrio no conhecimento geral/especializado: equilibra uma distribuição entre saberes gerais e especializados nos diversos níveis hierárquicos da prática sanitária.
Exclusão de práticas alternativas: anula ou restringe as práticas médicas não oficiais.	Inclusão de práticas alternativas: valoriza práticas alternativas eficazes e delibera os discursos de saúde popular e oficial.
Tecnificação do ato médico: valoriza a tecnologia independente da sua eficácia.	Adequação de tecnologia: utiliza tecnologias simples e/ ou complexas, mas eficazes e com custo social mínimo.
ênfase na medicina curativa: privilegia os processos fisiopatológicos em detrimento das causas (mais suscetíveis à incorporação tecnológica).	Integralidade da atenção: integra as ações promocionais, preventivas, curativas e reabilitadoras.

Lembrete: O paradigma clínico sempre terá ênfase no indivíduo, considerando a forma de curá-lo. No paradigma sanitário, a preocupação é com a coletividade em busca de prevenir e evitar as doenças.

Sistema Único de Saúde



OBJETIVOS

O sistema de saúde vigente é um modelo relativamente novo, culminado em um processo de mudanças que remonta à década de 1970, acelera-se ao longo dos anos 1980 e adquire estatuto institucional no fim da década de 1990. Ele é fruto de um processo interno de forte intensidade política e social, mas também influenciado por diversos modelos externos, em particular por aqueles vigentes nos Welfare States, nosso sistema foi estabelecido pela Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, sendo regulado pelas Leis nº 8.080 e nº 8.142, ambas de 1990. É conhecido como Sistema Único de Saúde (SUS) justamente porque a formulação correspondeu a uma unificação dos vários subsistemas existentes até então, superando a fragmentação institucional que prevalecia tanto no interior da esfera federal (saúde previdenciária, saúde pública etc.) quanto entre as diferentes esferas governamentais (federal, estadual e municipal) e também separando o setor estatal do setor privado.

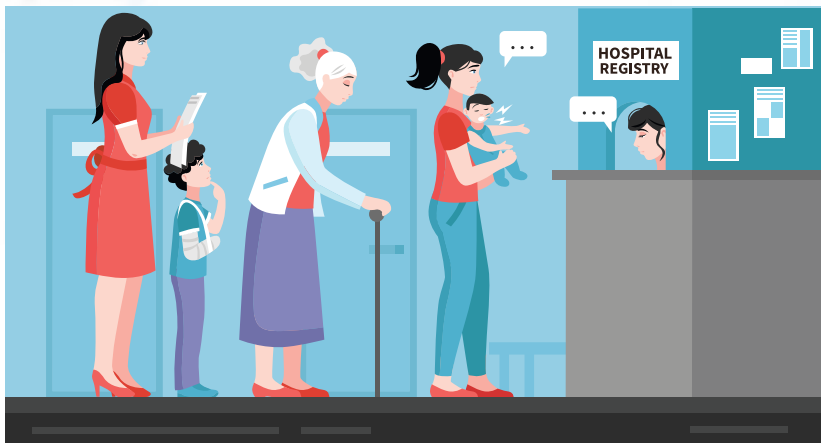
Por estabelecer princípios como a universalidade, a equidade e a integralidade da atenção e por criar diretrizes organizacionais de descentralização e de participação da sociedade, o SUS rompeu com o sistema anterior, que era excludente, pois atendia a população que apenas contribuía de alguma forma com o sistema de cobrança de impostos; além disso, o SUS fundou novas bases institucionais, gerenciais e assistenciais para o provimento das ações e dos serviços de saúde no País, considerados como direito universal da cidadania e dever do Estado.

O SUS foi desenhado e institucionalizado na contramão de uma tendência que, no plano internacional, já naquele momento apontava para uma revalorização do mercado como uma alternativa ao modelo clássico do Welfare, tido como inviável em razão da crise fiscal e de legitimidade do Estado. Enquanto o mundo discutia o ajuste estrutural da economia, a diminuição do aparelho do Estado e a contenção dos gastos públicos,

aqui, expandiam-se os direitos sociais e ampliava-se a responsabilidade estatal com o seu provimento.

Se, por um lado, a conjuntura interna de reconstrução democrática e resgate da dívida social legada pelos anos de ditadura dava suporte à expansão de direitos sociais – dentre os quais o da saúde –, foi inevitável que, ao ser implementado, o SUS se visse diante das limitações materiais e ideológicas impostas pela agenda da reforma do Estado que, introduzida no País no início dos anos 1990, ameaçava vetos às generosidades universalistas da Constituição de 1988.

Na verdade, o atual sistema de saúde no Brasil não é nem a aplicação literal do desenho legal do SUS, nem é fruto de prescrição estipulada de fora do processo social que o originou.



Fonte: Freepik

Antecedentes do SuS: breve trajetória

O SUS não se constituiu numa proveta social, como fruto da mente criativa de planejadores e políticos. Ao contrário, sua arquitetura institucional altamente inovadora corresponde a um processo social rico – em que se chocaram interesses e valores sociais diversos –, que suscitou

a renovação de crenças cognitivas relevantes, algumas delas inéditas na tradição das políticas públicas no Brasil.

Buscando no passado as origens e explicações para a sua configuração inovadora, é possível discriminar na genealogia do SUS dois movimentos tendenciais fortes que presidiram a evolução das políticas de saúde pelo menos nos últimos 30 anos.



IMPORTANTE

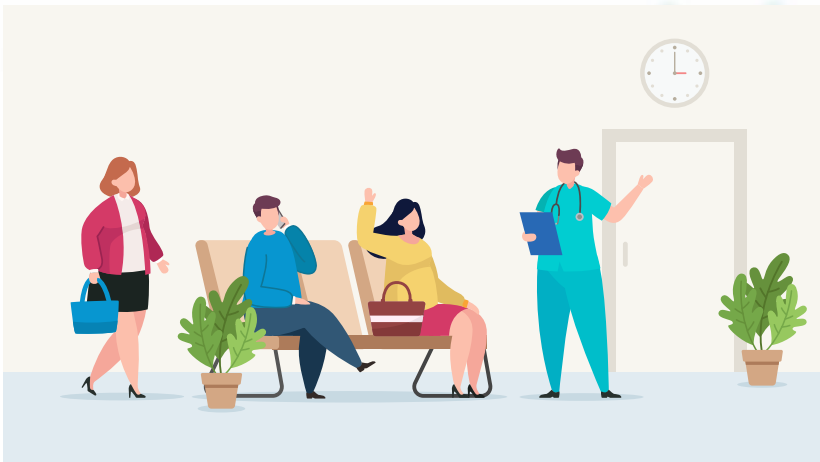
O primeiro, de caráter geral ao campo das políticas de proteção social, apontou em direção à sua universalização, ou seja, ao reconhecimento de direitos sociais vinculados à cidadania plena. Resultou na migração do modelo do seguro social que caracterizou, desde suas origens, o sistema previdenciário brasileiro, para o modelo da seguridade social, finalmente adotado na Constituição de 1988. O segundo movimento, de caráter específico ao setor de saúde, em busca de uma maior efetividade sanitária, envolveu a adoção de uma concepção mais ampla da saúde. Apontou para a transição de um modelo de atenção curativa à demanda para um modelo de atenção integral à população.

É conhecido o fato de que, até o fim da década de 1980, a definição de direitos sociais estava restrita à vinculação ao sistema previdenciário, sendo definidos como cidadãos os indivíduos pertencentes às categorias ocupacionais reconhecidas pelo Estado e que contribuíam para a Previdência Social. Isso porque, desde as décadas de 1930 e 1940, no período populista de Vargas, o desenvolvimento das políticas sociais se constituiu numa estratégia de incorporação de segmentos da classe média e trabalhadores urbanos ao projeto político de industrialização e modernização do País. Elas tiveram, então, grande visibilidade e impacto político, embora não tivessem conseguido, de fato, eliminar a pobreza ou implementar uma redistribuição significativa de renda.

Nesse contexto é que as categorias mais importantes de trabalhadores lograram, desde cedo, nos anos 1930, formar os primeiros

Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) que, contando com financiamento parcial do Executivo, constituíram-se nas principais organizações de política social no País. Entretanto, o acesso a elas e às suas sucessoras esteve limitado apenas aos membros da comunidade que se localizavam nas ocupações definidas em lei e que contribuíam para a Previdência. A extensão da cidadania fez-se mediante essa vinculação profissional, e não pelo reconhecimento da condição de membro da comunidade nacional. Não bastava ser brasileiro para gozar de direitos de cidadania social; antes era necessário “ter carteira assinada” e contribuir financeiramente para a Previdência Social, mediante uma modalidade de seguro (recebem benefícios somente aqueles que pagam por eles).

Havia, de fato, o estabelecimento de uma cidadania regulada, de caráter parcial e concedida por meio da articulação entre a política de governo e o movimento sindical. Dessa forma, acabaram excluídos da cidadania todos aqueles cuja ocupação a lei desconhecia: os trabalhadores na área rural e os trabalhadores urbanos cujas ocupações não estivessem reguladas.



Fonte: Freepik

Contudo, a tensão entre a manutenção de uma estrutura de privilégios e a necessidade de extensão dos chamados direitos sociais foi permanente no Brasil. Essa tensão ocorreu não só entre as categorias profissionais privilegiadas – bancários, comerciários, industriários, funcionários públicos, que mostravam marcantes diferenças de acesso entre si – como entre elas e o restante da população.

As origens da saúde previdenciária

A partir de 1945, com a industrialização crescente e com a liberação da participação política dos trabalhadores, ocorreu um aumento significativo e progressivo da demanda por atenção à saúde sobre todos os institutos.

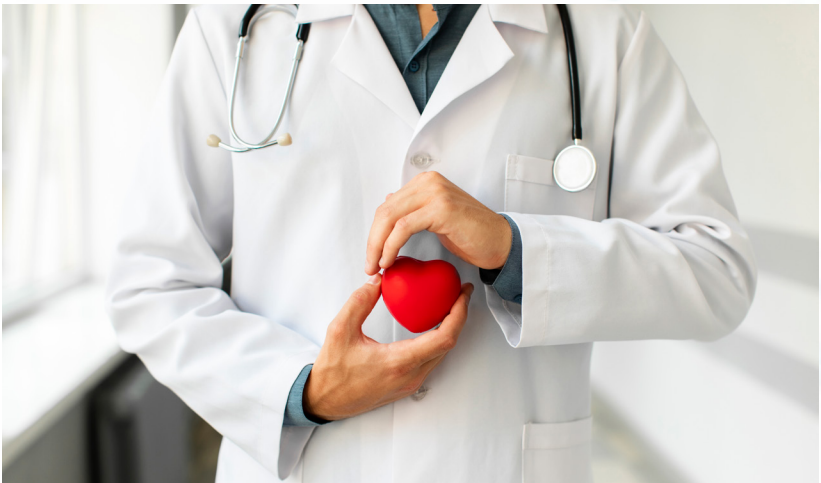
Tal processo de expansão culminou com a promulgação da Lei Orgânica da Previdência Social (Lops), em 1960, que promoveu a uniformização dos benefícios, ou seja, padronizou o cardápio de serviços de saúde a que todos os segurados teriam direito, independentemente do instituto a que estivessem filiados. Como a uniformização dos benefícios não foi seguida da unificação dos institutos e nem significou a universalização da atenção à saúde para toda a população, o resultado foi o aumento da irracionalidade na prestação de serviços, ao mesmo tempo em que a população não previdenciária continuava discriminada, não podendo ser atendida na rede da previdência.

Por força de uma resposta à demanda crescente por serviços de atenção individual, a política previdenciária de saúde, a essa época, já apresentava, como características marcantes, uma elevada concentração da rede própria nas grandes cidades do País e o caráter exclusivamente curativo do modelo da atenção médica.

A criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), em 1966, pelo governo militar, unificando todas as instituições previdenciárias setoriais, significou para a saúde previdenciária a consolidação da tendência da contratação de produtores privados de serviços de saúde, como estratégia dominante para a expansão da oferta de serviços.

Progressivamente, foram sendo desativados e/ou sucateados os serviços hospitalares próprios da Previdência, ao mesmo tempo em que se ampliava o número de serviços privados credenciados e/ou conveniados. O atendimento ambulatorial, no entanto, continuou como rede de serviços próprios e expandiu-se nesse período.

As consequências dessa política privatizante apareceram rapidamente, corroendo a capacidade gestora do sistema e reforçando a sua irracionalidade. De um lado, a baixa capacidade de controle sobre os prestadores de serviço contratados ou conveniados, já que cada paciente era considerado como um "cheque em branco", tendo a Previdência de pagar as faturas enviadas, após a prestação dos serviços; de outro lado, um planejamento racional que era quase impossível de ser feito, já que os credenciamentos não obedeciam a critérios técnicos, e sim a exigências políticas. Ao lado disso, explodiam os custos do sistema, tanto em razão da opção pela medicina curativa, cujos custos eram crescentes em função do alto ritmo de incorporação tecnológica, quanto em razão da forma de compra de serviços pela Previdência, realizada por meio das chamadas Unidades de Serviço que, além de valorizarem os procedimentos mais especializados e sofisticados, eram especialmente suscetíveis a fraudes, e cujo controle apresentava enorme dificuldade técnica.



Anos 1970: expansão e crise do modelo médico-previdenciário

A década de 1970 foi marcada por uma ampliação constante da cobertura do sistema, levando ao aumento da oferta de serviços médico-hospitalares e, conseqüentemente, a uma pressão por aumento nos gastos. Ao mesmo tempo, intensificavam-se os esforços de racionalização técnica e financeira do sistema.

A expansão da cobertura dava-se tanto pela incorporação de novos grupos ocupacionais ao sistema previdenciário (empregadas domésticas, trabalhadores autônomos e trabalhadores rurais) quanto pela extensão da oferta de serviços à população não previdenciária. A demanda crescente por serviços de saúde ocorrida no âmbito de um processo político de busca por legitimação do regime militar que, sobretudo a partir de 1974, com o II Plano Nacional de Desenvolvimento, implementou um esforço de incorporação da dimensão social em seu projeto de desenvolvimento econômico.

A criação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), em 1977, deu-se num contexto de aguçamento de contradições do sistema previdenciário, cada vez mais pressionado pela crescente ampliação da cobertura e pelas dificuldades de reduzir os custos da atenção médica, em face do modelo privatista e curativo vigente. A nova autarquia representou, assim como o conjunto do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (Sinpas), um projeto modernizante, racionalizador e de reformatação institucional de políticas públicas. Através de uma lógica sistêmica, pretendeu-se simultaneamente articular as ações de saúde entre si e estas com o conjunto das políticas de proteção social.

Já o Sistema Nacional de Saúde (SNS) foi criado pela Lei nº 6.229, de julho de 1975, e visou à superação da descoordenação imperante no campo das ações de saúde. O SNS foi constituído pelo “complexo de serviços, do setor público e do setor privado, voltados para ações de interesse da saúde [...] organizados e disciplinados nos termos desta lei” (BRASIL, 1975). Em relação à política pública de saúde, essa lei atribuía ao Ministério da Saúde a formulação da política, bem como a promoção ou execução de ações voltadas para o atendimento de interesse coletivo,

enquanto o Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), por meio do INPS (depois Inamps), responsabilizava-se, especialmente, pelas ações médico-assistenciais individualizadas.

O Serviço Nacional de Saúde foi mais um protocolo de especialização de funções do que um mecanismo de integração dos dois principais órgãos responsáveis pela política de saúde. Embora fosse atribuída ao Ministério da Saúde a função reitora na formulação da política de saúde, na prática, era o MPAS que, por deter a maior parte dos recursos públicos destinados à área da saúde, predominava na definição da linha política setorial.

Por sua vez, o Inamps, como o braço da saúde do Sinpas, teve suas ações condicionadas ou limitadas pela disponibilidade dos recursos existentes, já que os benefícios previdenciários (aposentadorias, pensões e outros benefícios), por sua natureza contratual, tinham primazia na alocação dos recursos do sistema. As despesas do Inamps, que em 1976 correspondiam a 30% do orçamento da Previdência Social, em 1982 atingiram apenas 20% do total, correspondendo a uma perda de um terço da participação nos gastos.

Assim, os anos 1970 marcaram a glória e a ruína do sistema de saúde brasileiro, tal como foi desenhado em meados dos anos de 1960, no âmago do processo de modernização conservadora experimentada pelo estado brasileiro sob a vigência do regime autoritário. A crise se agravaria nos anos seguintes, abrindo caminho para a reforma do sistema.



Os anos 1980 e a transição para a seguridade social

O Inamps entra, na década de 1980, vivendo o agravamento da crise financeira e tendo de equacioná-la, não simplesmente como gestor da assistência médica aos segurados da Previdência, mas como o responsável pela assistência médica individual ao conjunto da população. Ou seja, a crise deveria ser enfrentada num contexto não apenas de extensão de benefícios a alguns setores, mas de universalização progressiva do direito à saúde e do acesso aos serviços.

O aumento de serviços e gastos, decorrentes dessa ampliação de cobertura, teria de ser enfrentado num quadro de redução das receitas previdenciárias, provocada pela política econômica recessiva, que desde 1977 reduzia a oferta de empregos a massa salarial e levava ao esgotamento das fontes de financiamento baseadas na incorporação e nos contingentes de contribuintes.

Nesse quadro, a estratégia racionalizadora privilegiou, de um lado, o controle de gastos via combate a fraudes e outras evasões e, de outro, a contenção da expansão dos contratos com prestadores privados, passando a favorecer o setor público das três esferas governamentais.

Para o combate às fraudes, já havia sido criada no MPAS a Empresa de Processamento de Dados da Previdência, Dataprev, encarregada de processar também as contas hospitalares. Por meio de instrumentos cada vez mais sofisticados de controle, procurou-se reduzir o volume de fraudes, ainda que tais mecanismos fossem incapazes de reduzir o custo da atenção prestada.

Na área da assistência médica, o esforço de adequar oferta e demanda, sem aumentar o déficit financeiro da Previdência, direcionou-se para o estabelecimento de convênios com outros órgãos públicos de saúde, pertencentes ou às Secretarias de Saúde, ou ao Ministério da Saúde, ou às universidades públicas. Além de prestarem os serviços a um custo inferior à rede privada, a forma repasse de recursos do Inamps para os serviços públicos conveniados, via orçamento global, permitia

maior controle e planejamento dos gastos. Dessa forma, o Inamps iniciava um processo de integração da rede pública que viria a culminar com a dissolução das diferenças entre a clientela segurada e a não segurada.

Em 1981, o agravamento da crise financeira da Previdência Social provocou uma intensificação do esforço de racionalizar a oferta de serviços, o que acentuou a tendência anterior de integração da rede pública de atenção à saúde.

O marco inicial desse período é a criação do Conselho Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária (Conasp), por meio do Decreto nº 86.329/81. Composto por notáveis da medicina e por representantes de vários ministérios, de trabalhadores e dos empresários, o Conasp recebeu a missão de reorganizar a assistência médica, sugerir critérios de alocação de recursos no sistema de saúde, estabelecer mecanismos de controle de custos e reavaliar o financiamento da assistência médico-hospitalar. Estabeleceu, então, um conjunto de medidas racionalizadoras, fixou parâmetros de cobertura assistencial e de concentração de consultas e hospitalizações por habitante, além de medidas para conter o credenciamento indiscriminado de médicos e hospitais.

Os dois programas mais importantes do Conasp foram a implantação do Sistema de Atenção Médico-Hospitalar da Previdência Social (SAMHPS) e o das Ações Integradas de Saúde (AIS), o primeiro voltado a disciplinar o financiamento e o controle da rede assistencial privada contratada; o segundo, com a finalidade de revitalizar e racionalizar a oferta do setor público, estabelecendo mecanismos de regionalização e hierarquização da rede pública das três esferas governamentais, até então completamente desarticuladas.

Enquanto o SAMPHS permitia melhorar os controles institucionais sobre os gastos hospitalares, viabilizando maior racionalidade para planejar, as AIS constituíam-se como principal caminho de mudança estratégica do sistema. A partir desse último programa, o sistema caminhou progressivamente para a universalização das clientelas, para a integração/unificação operacional das diversas instâncias do sistema público e para a descentralização dos serviços e ações em direção aos municípios.

Desse modo, pode-se dizer que, sob a pressão da crise financeira, gestou-se no interior da Previdência e do Inamps um processo de reforma que, embora inicialmente movido pela necessidade da contenção financeira, terminou ampliando-se e incorporando elementos críticos sobre a estrutura do sistema, fosse pelo seu caráter privatista, fosse pelo caráter médico-hospitalocêntrico. Isso se deu num quadro de perda crescente de legitimidade social e política do sistema, em razão de sua ineficiência e de sua baixa efetividade, e viabilizou-se pela presença de técnicos e intelectuais progressistas no interior da máquina burocrática, inspirados nas propostas de equidade e expansão do direito à saúde, então sintetizadas no lema internacional da "Saúde para todos até o ano 2000".

Embora as AIS fossem financeiramente um programa marginal do Inamps – em 1984, representavam 6,2% do orçamento, enquanto a rede privada contratada recebia em torno de 58,3%, foi através delas que se construiu uma base técnica e se formularam os princípios estratégicos que resultaram nas mudanças institucionais ocorridas no fim da década.



IMPORTANTE

As AIS demarcaram também o início de um processo de coordenação intersetorial e de gestão colegiada entre as esferas de governo e os órgãos setoriais do governo federal.

Esse movimento de expansão das AIS, no biênio 1985-1986, correspondeu ao período de maior efervescência dos debates sobre as formas de organização das políticas sociais na Nova República, que terminaram por fazer prevalecer a estratégia da descentralização de competências, recursos e gerência relativos aos diversos programas setoriais. Expresso no I Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República, o princípio da descentralização, cuja implementação foi liderada pela saúde, ao mesmo tempo em que impulsionou e fortaleceu o modelo de reorganização da assistência expresso pelas AIS, começou a colocar em xeque o próprio Inamps, uma vez que nele permaneceu concentrado um amplo poder, baseado, sobretudo no monopólio do

relacionamento com o setor privado que continuava representando a maior parte tanto da oferta hospitalar quanto dos recursos financeiros.

A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em março de 1986, alcançou grande representatividade e cumpriu o papel de sistematizar tecnicamente e de disseminar politicamente um projeto democrático de Reforma Sanitária, dirigido à universalização do acesso, equidade no atendimento, integralidade da atenção, unificação institucional do sistema, descentralização, regionalização e hierarquização da rede de serviços e participação da comunidade.

Em julho de 1987, foram criados os Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde (SUDS), por meio do Decreto nº 95.657. Os debates e as iniciativas de reorganização do pacto federativo no País, assim como os resultados eleitorais de novembro de 1986, criaram o clima favorável a essa medida que apontava os estados e municípios como os gestores do futuro sistema de saúde.



SAIBA MAIS

Para compreender melhor toda a histórica político-administrativa e a crise nos modelos de saúde no Brasil, assista ao filme a seguir: <https://www.youtube.com/watch?v=NzZYtoSZANs>

O programa do SUDS representou a extensão legal da ideia de assistência médica previdenciária, redefinindo as funções e atribuições das três esferas gestoras no campo da saúde, reforçando a descentralização e restringindo o nível federal apenas às funções de coordenação política, planejamento, supervisão, normatização e regulamentação do relacionamento com o setor privado. Quanto ao Inamps, esse programa estabeleceu a progressiva transferência aos estados e municípios de suas unidades, recursos humanos e financeiros, atribuições de gestão direta e de convênios e contratos assistenciais, e promoveu sua completa reestruturação para cumprir funções de planejamento, orçamento e acompanhamento.

A nova Constituição Federal de 1988 instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), cuja formatação final e regulamentação ocorreram mais tarde, em 1990, com a aprovação das Leis nº 8.080 e 8.142.

O ano de 1989, entretanto, junto com o retrocesso político ocasionado pelo fracasso de sucessivos planos econômicos de combate à inflação, assistiu a um recrudescimento das resistências do setor privado e da burocracia federal até a dissolução das atribuições e dos recursos do Inamps nas esferas estadual e municipal. O grupo progressista foi deslocado do comando do órgão, em que grupos conservadores estabeleciam uma última trincheira pela preservação de sua estrutura e de suas funções. A ausência de um projeto claro de restauração do sistema anterior, assim como o crescente peso político de novos atores na arena setorial, como os secretários municipais e estaduais de saúde, organizados em entidades nacionais (Conselhos Nacional de Secretários Municipais de Saúde – Conasems e Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde – Conass), fez com que tais resistências tivessem pouco fôlego.

Em 7 de março de 1990, na última semana do Governo Sarney, o Inamps foi finalmente transferido do Ministério da Previdência Social e Assistência Social para o Ministério da Saúde. A partir daí, a presidência da autarquia passou a ser exercida pela Secretaria da Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, numa progressiva diluição de sua identidade institucional. O processo de formatação e operacionalização do SUS nos estados e municípios, por meio das Normas Operacionais Básicas (NOBs), de 1991 e 1993, que formalizavam a transferência da gestão da saúde a essas esferas governamentais, tinham nas Comissões Intergestores Tri e Bipartites o espaço institucional de distribuição pactuada de recursos e atribuições entre os níveis federal, estadual e municipal.

A extinção legal do Inamps, ocorrida em julho de 1993, deu-se de forma quase natural, como consequência de seu desaparecimento orgânico e funcional no emergente SUS.

A institucionalização do SuS: marcos legais e históricos

A nova institucionalidade do setor saúde começou a ser desenhada em 1986, por ocasião da VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília, com cerca de três mil participantes. Nessa conferência, precedida de sessões nos estados, foram estabelecidos os fundamentos do futuro SUS. Realizada em meio a amplos debates na imprensa, nos sindicatos, nos partidos políticos de oposição, nas instituições de ensino e pesquisa e em movimentos populares, a conferência contribuiu decisivamente para formar consensos quanto ao diagnóstico crítico sobre o sistema de saúde vigente e quanto a uma agenda de mudanças, que ficou conhecida como a Agenda da Reforma Sanitária.

Seu relatório geral resultou de discussões em plenário e em grupos de trabalho. Consagrou a saúde como direito universal e como dever do Estado, tendo como fundamento a noção de cidadania. No plano das relações entre os níveis de governo, a estratégica das AIS, seguida pelos SUDS, prevaleceu como diretriz básica para assegurar a descentralização e a mudança de ênfase no financiamento ao setor. O amplo consenso então formado foi a base do futuro texto constitucional.

Todo esse processo possibilitou que o debate na Assembleia Nacional Constituinte sobre saúde fosse pautado por uma proposta de mudanças mais orgânicas e articuladas do que a maioria dos outros setores de políticas públicas.

Assim, com a nova Constituição de 1988, foi fundado o arcabouço jurídico-institucional do SUS, consagrando em grande parte os preceitos acordados por ocasião da VIII Conferência Nacional de Saúde. Tal arcabouço está estabelecido no capítulo sobre a Seguridade Social da Constituição Federal de 1988 e detalhado na Lei nº 8.080, de 1990, sobre a organização dos serviços, e na Lei nº 8.142, também de 1990, sobre a participação comunitária e financiamento do sistema. Diversas portarias ministeriais regulamentaram o SUS, especialmente as que originaram as NOBs de 1991, 1993 e 1996. A implantação do SUS no conjunto do País passa a acontecer de forma gradual ao longo dos anos 90.

A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 apresenta, na sua Seção II, os preceitos que governarão a política setorial nos anos seguintes. Sob o lema "Saúde: direito de todos, dever do Estado", seus princípios podem ser resumidos em alguns pontos básicos: as necessidades individuais e coletivas são consideradas de interesse público e seu atendimento, um dever do Estado; a assistência médico-sanitária integral passa a ter caráter universal e destina-se a assegurar a todos o acesso aos serviços; esses serviços devem ser hierarquizados segundo parâmetros técnicos e a sua gestão deve ser descentralizada.



Fonte: Freepik

O sistema deverá ser custeado, essencialmente, por recursos governamentais originários da União, estados e municípios. Os serviços de caráter empresarial comprados devem ser complementares e devem estar subordinados às estratégias mais gerais da política setorial. As ações governamentais serão submetidas a organismos colegiados oficiais, os Conselhos de Saúde, que são a representação paritária entre usuários e prestadores dos serviços. Serão consagradas a descentralização político-administrativa e a participação social.

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, "dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências" (BRASIL, 1990a), ou seja, detalha o conteúdo constitucional. Essa lei define os papéis institucionais de cada esfera governamental no plano da gestão, a estrutura de financiamento e as regras de transferência de recursos entre os diferentes níveis de governo, por meio dos Fundos de Saúde. Com relação ao modelo proposto, o caráter automático e imediato das transferências entre os diferentes fundos de saúde ficou prejudicado em virtude do veto governamental, sendo retomado pela Lei nº 8.142. Promulgada em 28 de dezembro de 1990, essa lei "dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências" (BRASIL, 1990b). Ela institui os Conselhos de Saúde e confere status público aos organismos de representação de governos estaduais e municipais, como o Conass e o Conasems. Falaremos dessas entidades mais adiante, e também das comissões intergestores, mas lembre-se de que as articulações entre esferas de governo já estavam sendo realizadas desde os anos 1980, à época da AIS.

Lembrete: O SUS, com suas diretrizes operacionais, pode ser representado como um novo pacto social, um novo desempenho político-institucional e um novo modelo técnico-assistencial.

O SUS como novo pacto social.

Com o novo pacto social, a saúde passa a ser definida como um direito de todos – integrante da condição de cidadania social – e também considerada um dever do Estado, implicando uma responsabilidade e solidariedade do conjunto da sociedade. Distingue-se do modelo anterior, que se baseava na ideia de seguro social, em que o direito estava restrito às clientela envolvidas diretamente com o financiamento do sistema, por meio das contribuições previdenciárias.

Nesse novo pacto, configura-se o modelo da Seguridade Social, em que as clientela são beneficiadas independentemente de sua contribuição ao financiamento do sistema, porque é assumido pelo conjunto da sociedade. Ele corresponde a uma requalificação do direito à saúde, que deixa de ser privilégio dos contribuintes da Previdência e estende-se a todos os cidadãos, e a uma requalificação da responsabilidade do Estado, que deixa de ser uma mera agência do seguro social em saúde e passa a ser o responsável pela sua garantia a todos os cidadãos.

No plano do arcabouço legal, o direito de todos manifesta-se na garantia do acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, isto é, nos preceitos da universalidade e da equidade. O dever do Estado expressa-se em um pacto de solidariedade do conjunto da sociedade e funda-se num novo modelo de financiamento.

A Constituição Federal estabelece:

Art. 196. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre regulamentação, fiscalização e controle devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (BRASIL, 1988a).

Quanto ao novo modelo de financiamento, está estabelecido que a responsabilidade pelo financiamento do SUS seja das três esferas de governo e que cada uma deve assegurar o aporte regular de recursos ao respectivo fundo de saúde.

Conforme determina o Art. 194 da Constituição Federal, a Saúde integra a Seguridade Social, juntamente com a Previdência e Assistência Social. No inciso IV do parágrafo único desse mesmo artigo, está determinado que a Seguridade Social seja organizada pelo poder público, observada a “diversidade da base de financiamento” (BRASIL, 1988a).

Já o Art. 195 determina que a Seguridade Social seja financiada com recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de contribuições sociais, sendo as principais fontes específicas da Seguridade aquelas que incidem sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro.

Nas esferas estadual e municipal, além dos recursos oriundos dos respectivos tesouros, o financiamento do SUS conta com recursos transferidos pela União aos estados e pela União e estados aos municípios.

Giovanella e Fleury (1996) relacionam a universalização da atenção pública com a expansão de clientela dos planos e seguros privados. A deterioração dos serviços de saúde, decorrente do desinvestimento na rede pública, agora sobrecarregada com usuários até então excluídos, teria empurrado setores de classe média e trabalhadores especializados a buscarem melhor qualidade na esfera privada. A isso se chamou “universalização excludente” (FAVERET, 1990). Na verdade, a expansão dos planos foi muito facilitada por incentivos governamentais, como o abatimento do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas.

O SUS como novo desenho político - institucional

O novo desenho político-institucional refere-se à ideia de que a implementação do novo sistema de saúde, agora universal, deveria dar-

se de forma inovadora, com estruturas ágeis e compatíveis com as novas tarefas e compromissos do sistema. Deveria superar a fragmentação institucional, o centralismo gerencial e o padrão burocrático de decisão e de execução de ações do modelo anterior. A remodelação institucional proposta foi concebida sob a inspiração de um novo padrão de relação estado-sociedade, de forma a viabilizar a responsabilidade pública sobre a saúde.

Ao desenhar uma nova forma de exercer a gestão pública da saúde, buscando melhorar o desempenho do Estado, pode-se dizer que a reforma sanitária antecipava alguns dos preceitos que mais tarde estariam presentes na Agenda de Reforma do Estado, pelo menos nas suas prescrições mais voltadas para melhorar o desempenho estatal no exercício da responsabilidade pública. Buscava-se um novo formato do Estado de modo a favorecer sua agilidade e permeabilidade à sociedade.

Além da unificação dos comandos institucionais, as categorias que deram eixo ao novo design foram a descentralização e a participação. Os marcos nesse contexto são dados pelas Leis nº 8.080/90 e 8.142/90, que detalham o desenho e estabelecem os mecanismos operacionais para a descentralização político-administrativa e para a participação por meio dos conselhos.

Quanto à unificação/descentralização, a legislação é bastante clara ao definir a situação objetivo da direção única em cada esfera de governo. A Lei nº 8.080/90 define em seu artigo 7 diversos princípios, entre os quais:

IX – Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:



Fonte: Freepik (layout)

A participação manifesta-se na obrigatoriedade da constituição de Conselhos de Saúde em todos os níveis de governo e na sua definição como membros do Poder Executivo.

A Lei nº 8.142/90 "dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências" (BRASIL, 1990b). Em seu artigo 1º, parágrafo 2, lê-se que:

O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo (BRASIL, 1990b).

**IMPORTANTE**

Os conselhos gestores de saúde sempre deverão ser compostos por 50% do seu quadro com representação da população, 25% dos trabalhadores e 25% do governo.

Trata-se, portanto, de um organismo oficial que é parte do Executivo. O chamado caráter paritário decorre de regras de composição dos conselhos: uma metade dos conselheiros deve ser representante dos usuários e a outra, dos setores que oferecem e executam os serviços, ou seja, um conjunto composto pelos profissionais, os prestadores e os representantes governamentais.

Alguns obstáculos são, muitas vezes, apontados para a efetiva participação dos conselhos no processo decisório da política de saúde: resistências do Executivo, renúncia de grupos sociais à participação cotidiana, falta de informações para um funcionamento adequado ou insuficiência de capacitação dos conselheiros.

Além do Conselho Nacional de Saúde que, em seus quase dez anos de existência firmou-se como um fórum privilegiado no processo decisório da saúde, esse tipo de organismo vem-se disseminando rapidamente pelo País. O início dos anos 1990 marcou a proliferação veloz de conselhos. Entre 1991 e 1993, foram constituídos cerca de dois mil Conselhos de Saúde, o que significa um ritmo de praticamente dois novos conselhos por dia. Em julho de 1996, uma estimativa baseada no número de municípios já habilitados à municipalização da saúde sugeriu que cerca de 65% deles dispunham de conselhos, correspondendo a mais de 80% da população brasileira.

No fim de 1998, esses organismos encontravam-se largamente disseminados no País, estimando-se que existiam em mais de 4.000 municípios, envolvendo algo em torno de 80 a 100 mil postos de conselheiros de saúde, número equivalente ao de vereadores no conjunto do País. Some-se a isso a existência de conselhos estaduais de saúde em todas as unidades da Federação.

SUS como novo modelo técnico-assistencial

O novo modelo técnico-assistencial baseia-se numa concepção ampliada do processo saúde-doença, em que o acesso a bens e serviços de saúde é apenas um dos componentes de um processo que depende essencialmente de políticas públicas mais amplas capazes de prover qualidade de vida. Distingue-se do modelo anterior, que dissociava inteiramente as ações preventivas das ações curativas e a saúde coletiva da atenção individual e era inteiramente centrado no atendimento à demanda por assistência médica.

Além do artigo 196, que vincula o direito à saúde à implementação de “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos [...]” (BRASIL, 1988a), a Constituição estabelece:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
- atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
- participação da comunidade (BRASIL, 1988a).

A Lei nº 8.080/90, em diversas passagens, especifica o entendimento da atenção integral:

Art. 7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no Art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

I - Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

II – Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema (BRASIL, 1990a).

A integralidade da assistência em saúde inclui quatro ações:

- a articulação entre os níveis de atenção, garantindo a primazia das ações de promoção e prevenção, e também as de assistência a doentes;
- a articulação entre as unidades de uma rede, das mais básicas às mais complexas tecnologicamente, seguindo uma distribuição e um ordenamento espacial compatível com a demanda populacional de cada território (regionalização e hierarquização), garantindo a referência e contrarreferência;
- a articulação em cada unidade (entre os serviços) e em cada serviço (entre as diversas ações), visando a uma ação integrada para cada problema e para cada indivíduo ou coletividade coberta;
- a oferta de serviços cuja organização atenda à demanda espontânea e a programação de ações para problemas prioritários.

A integralidade importa, assim, numa oferta adequada e oportuna de recursos tecnológicos necessários para prevenir ou para resolver problemas de saúde, no âmbito dos indivíduos ou no das coletividades. No entanto, esse talvez tenha sido o aspecto menos desenvolvido no SUS. Nem a legislação é exaustiva a respeito, nem as sucessivas NOBs lograram enfrentar a questão da reformatação dos processos de trabalho no interior do SUS, haja vista a grande pressão provocada tanto pela tradição assistencial dos profissionais quanto pela demanda reprimida por assistência médica.

Os anos 1990 e a implantação do SUS: desafios e inovações

Os anos 1990 são aqueles em que o modelo proposto enfrenta o teste da realidade. É interessante notar que o processo de regulamentação do SUS, feito por meio das Normas Operacionais Básicas (NOBs), foi gerando efeitos sobre sua configuração institucional, ora confirmando e reforçando aspectos previstos, ora desvirtuando seu desenho original, muitas vezes apontando para mudanças importantes em sua lógica. É claro que isso sempre ocorre nas políticas públicas, já que elas incidem e geram efeitos sobre indivíduos e grupos sociais que têm e lutam por seus próprios interesses e valores, mesmo que não seja de forma organizada ou ativa.

A implantação do SUS desenvolve-se numa conjuntura muito diferente daquela em que se deu a sua concepção e institucionalização. Em função disso, nos primeiros anos dessa década, o SUS viveu momentos paradoxais, expressivos das tensões suscitadas por implementação.

Nascido no ambiente democratizante da Nova República, característico do fim dos anos 1980, sua operacionalização teve de enfrentar os ventos desfavoráveis do ajuste estrutural da economia e da crise fiscal e de legitimidade do Estado que, já há alguns anos, situava-se no epicentro das cidades da Europa e dos Estados Unidos, manifestando-se na maré do pensamento e das práticas de neoliberalismo.



Os movimentos nesse período foram presididos por dois instrumentos legais, a saber: as NOBs 01/91 e 01/93, chamadas respectivamente de NOB-SUS-91 e NOB-SUS-93, editadas pelo Ministério da Saúde.

A NOB-SUS-91 veio com a finalidade de disciplinar e padronizar os fluxos financeiros entre as esferas de governo e pretendeu combater a propalada ineficiência das redes públicas federal, estadual e municipal, acusadas de ociosas e caras. Para tanto, universalizou nas relações intergovernamentais o pagamento por produção de serviços em substituição ao pagamento por orçamento, até então vigente por meio de convênios. As unidades próprias de estados e municípios, inclusive as transferidas, passariam a ser financiadas de acordo com a sua produção, por meio da mesma sistemática e das mesmas tabelas de procedimentos vigentes para a rede privada contratada e conveniada ao SUS.

A NOB-SUS 91 representou o primeiro ato normativo de envergadura nacional no âmbito do SUS e teve impacto significativo: por um lado, representou um retrocesso na medida em que:

- recentralizou o sistema para o plano federal, retirando a pouca autonomia dos gestores estaduais e municipais, submetendo-os, como meros prestadores, aos preceitos e tabelas federais de remuneração de serviços, perdendo a condição de cogerentes ou parceiros na gestão do SUS;
- estimulou um produtivismo médico-assistencial em que, junto com eventuais melhorias de produtividade, embutiram-se os aumentos de exames negativos, procedimentos desnecessários e até atitudes fraudulentas de faturamento.

Por outro lado, impulsionou a capacitação municipal para a gestão, pois criou a configuração do município e do estado "habilitados" à gestão descentralizada e passou a exigir para o acesso aos recursos financeiros federais o cumprimento de pontos considerados fundamentais para a implantação do SUS, como a gestão municipalizada de unidades federais e estaduais, o funcionamento do Conselho de Saúde e do Fundo de

Saúde e o desenvolvimento de estrutura técnica de gestão, tais como os sistemas de informação e de vigilância epidemiológica.

Podem ser considerados os seguintes efeitos positivos nesse período:

- a criação de um enorme incremento, sobretudo na esfera municipal, de uma capacidade institucional e técnica para a gestão da saúde, inédita na história e na cultura municipal do País;
- a emergência de novos atores sociais na arena da saúde, com peso crescente no processo decisório, como os secretários municipais e diversos grupos de usuários, por meio dos conselhos municipais de saúde.

A NOB-SUS-93 situou-se em um contexto político bastante diferente, em que o governo procurava restaurar o compromisso com a implementação do SUS, tal como tinha sido desenhado originalmente. Ela instituiu os níveis progressivos de gestão local do SUS e representou um divisor de águas nos anos 1990.

Tomando-se por base o documento *Descentralização das Ações e Serviços de Saúde: a Ousadia de Cumprir e Fazer Cumprir a Lei* (1993), do Conselho Nacional de Saúde, a NOB estabeleceu um conjunto de estratégias que consagraram a descentralização político-administrativa na saúde. Estabeleceu-se uma municipalização progressiva e gradual, em estágios, de forma a contemplar os diversos graus de preparação institucional e técnica dos municípios para assumir a gestão da saúde. Cada estágio correspondia a certo número de requisitos gerenciais a serem cumpridos pelo município, a que então cabia uma autonomia crescente na gestão dos recursos, incluindo os da rede privada contratada.

Pela NOB-SUS-93, o SUS teve a sua execução descentralizada por níveis de gestão, começando pela incipiente, seguida pela parcial e culminando na semiplena. A progressão decorreu do comprometimento de estados e municípios com a organização da atenção à saúde, com

sua adequação a parâmetros de programação e refletiu-se em maior autonomia local para dispor de recursos. Na prática, a gestão parcial não gerou maiores consequências. A semiplena, no fim de 1996, havia sido alcançada por quase 150 municípios, abrangendo cerca de 20% da população brasileira, e representou a transferência direta de recursos para esses municípios, com maior autonomia de sua utilização.

Pode-se dizer que, em meados da década de 1990, o SUS apresentava um balanço positivo em seu processo de implantação, apesar de as opiniões serem muito diversas e refletirem o crescimento dos próprios estudos sobre a sua implantação. Além disso, as discussões sobre a saúde extrapolam o limite acadêmico e aparecem nos meios de comunicação, pois interessam aos políticos, às lideranças sociais, aos médicos, aos enfermeiros, aos economistas e a muitos outros.

A palavra crise ronda o sistema desde o nascedouro e reflete as aspirações sociais não contempladas.

Porém, ao longo desse período, sem dúvida, contabilizaram-se alguns pontos favoráveis:

- ocorreu grande extensão de programas de saúde pública e de serviços assistenciais para o conjunto da população, incorporando itens de alta complexidade, que antes estavam restritos aos contribuintes da previdência social;
- foi desencadeado um efetivo processo de descentralização política e administrativa, que pode ser observado pela progressiva municipalização do sistema e pelo desenvolvimento de organismos colegiados intergovernamentais;
- houve incorporação de usuários ao processo decisório, especialmente a partir da disseminação de Conselhos de Saúde;
- ampliaram-se imensamente as discussões sobre saúde na sociedade.

No entanto, é preciso reconhecer problemas de saúde ainda não resolvidos. Entre os principais obstáculos estão a falta de mecanismos mais eficientes na transferência financeira e de mais clareza nas regras para o comprometimento dos orçamentos da União, dos estados e dos municípios com as políticas de saúde. Além disso, a qualidade dos serviços é muito desigual e o que funciona adequadamente é dissolvido no mar de irregularidades, na falta de serviços essenciais e nas dificuldades encontradas pelos usuários em se deslocarem no interior do SUS, sobretudo quando necessitam de tratamentos mais complexos.

As falhas do SUS repercutem, portanto, no seu mais visível ponto fraco: o acesso e a utilização de serviços. Forma-se então um consenso entre os atores relevantes a respeito da questão do financiamento, tanto na definição de montantes e fontes quanto na divisão de responsabilidades entre as esferas e os diversos segmentos da sociedade. É sabido que a composição das fontes que sustentam a saúde ainda é fortemente regressiva, refletindo as distorções do sistema fiscal brasileiro. Atualmente, os recursos financeiros são insuficientes.

Também há um consenso sobre a questão da oferta, que deveria ser reorientada no sentido de garantir ou de facilitar o acesso das populações mais necessitadas, de propiciar resolutividade e acesso aos serviços de maior complexidade e atingir os segmentos mais necessitados – cobertura mais resolutividade e qualidade.

O SUS e a NOB-96

A NOB-96 vem representar a aproximação mais explícita com a proposta de um novo modelo de atenção. Para isso, ela acelera a descentralização dos recursos federais em direção aos estados e municípios, consolidando a tendência à autonomia de gestão das esferas descentralizadas, e cria incentivos explícitos às mudanças na lógica assistencial, rompendo com o produtivismo e implementando incentivos aos programas dirigidos às populações mais carentes, como o Programa Agentes Comunitários de Saúde – Pacs e às práticas fundadas numa nova

lógica assistencial, como o Programa Saúde da Família, hoje consolidado como Estratégia Saúde da Família, ESF.

A seguir, um trecho da introdução da NOB-g6.

[...] (os ideais de saúde) foram transformados, na Carta Magna, em direito à saúde, o que significa que cada um e todos os brasileiros devem construir e usufruir de políticas públicas – Econômicas e sociais – que reduzam riscos e agravos à saúde. Esse direito significa, igualmente, o acesso universal (para todos) e equânime (com justa igualdade) a serviços e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde (atendimento integral).

A NOB-g6 fixa como finalidade primordial promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes, [...] com a consequente redefinição das responsabilidades dos estados, do Distrito Federal e da União, avançando na consolidação dos princípios do SUS.

Esse exercício, viabilizado com a imprescindível cooperação técnica e financeira dos poderes público estadual e federal, compreende, portanto, não só a responsabilidade por algum tipo de prestação de serviços de saúde, como, da mesma forma, a responsabilidade pela gestão de um sistema que atenda, com integralidade, à demanda das pessoas pela assistência à saúde e às exigências sanitárias ambientais [...].

Busca-se dessa forma, a plena responsabilidade do poder público municipal que tanto se responsabiliza como pode ser responsabilizado, ainda que não isoladamente. Os poderes públicos estadual e federal são sempre corresponsáveis, na respectiva competência ou ausência da função municipal (inciso II do Artigo 23, da Constituição Federal). Essa responsabilidade, no entanto, não exclui o papel da família, da comunidade e dos próprios indivíduos na promoção, proteção e recuperação da saúde.

Isso implica aperfeiçoar a gestão dos serviços de saúde no País e a própria organização do Sistema visto que o município passa a ser, de fato, o responsável imediato pelo atendimento das necessidades e das demandas de saúde da sua população e das exigências de intervenções saneadoras em seu território.

Ao tempo em que aperfeiçoa a gestão do SUS, essa NOB aponta para uma reordenação do modelo de atenção à saúde, na medida em que redefine:

- os papéis de cada esfera de governo e, em especial, no tocante à direção única;
- os instrumentos gerenciais para que municípios e estados superem o papel exclusivo de prestadores de serviços e assumam seus respectivos papéis de gestores do SUS;
- os mecanismos e fluxos de financiamento, reduzindo progressiva e continuamente a remuneração por produção de serviços e ampliando as transferências de caráter global, fundo a fundo, com base em programações anteriores ascendentes, pactuadas e integradas;
- a prática do acompanhamento, controle e avaliação do SUS, superando os mecanismos tradicionais, centrados no faturamento de serviços produzidos e valorizando os resultados advindos de programações com critérios epidemiológicos e desempenho com qualidade;
- os vínculos dos serviços com os seus usuários, privilegiando os núcleos familiares e comunitários, criando, assim, condições para uma efetiva participação e controle social.

De forma inédita, a NOB-96 incorpora a concepção de saúde estabelecida constitucionalmente, mas jamais operacionalizada.

A atenção à saúde, que encerra todo o conjunto de ações levadas a efeito pelo SUS, em todos os níveis de governo, para o atendimento das demandas pessoais e das exigências ambientais, compreende três grandes campos, a saber:

- o da assistência, em que as atividades são dirigidas às pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada no âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como em outros espaços, especialmente no domiciliar;

- o das intervenções ambientais, no seu sentido mais amplo, incluindo as relações e as condições sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, o controle de vetores e de hospedeiros e a operação de sistemas de saneamento ambiental;
- o das políticas externas ao setor saúde, que interferem nos determinantes sociais do processo saúde-doença das coletividades, de que são partes importantes às questões relativas às políticas macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à educação, ao lazer, à disponibilidade e à qualidade dos alimentos (BRASIL, 1996).

A NOB-96 acrescenta que:

[...] as ações de política setorial em saúde, bem como as administrativas – planejamento, comando e controle – são inerentes e integrantes do contexto daquelas envolvidas na assistência e nas intervenções ambientais. Ações de comunicação e de educação também compõem, obrigatória e permanentemente, a atenção à saúde.

Nos três campos referidos, enquadra-se, então todo o espectro de ações compreendidas nos níveis de atenção à saúde, representados pela promoção, pela proteção e pela recuperação, nos quais deve ser priorizado o caráter preventivo (BRASIL, 1996).

A NOB-96 estabelece ainda uma divisão e um compartilhamento formal de responsabilidades entre as esferas de governo. O desempenho dos papéis que cabem aos gestores concretiza-se mediante um conjunto de responsabilidades, caracterizando a ideia principal do novo modelo, que é a responsabilização de cada gestor, de cada instância de governo. Esse novo modelo de gestão configura, assim, um instrumento altamente favorecedor na implantação de um novo modelo de atenção à saúde, até então centrado na doença.

Nessa transformação, destaca-se a atenção integral, uma vez que o modelo abarca o conjunto das ações e dos serviços de promoção, de

proteção e de recuperação da saúde, evidenciando, assim, o diferencial entre a NOB-96 e as anteriores, que tinham como foco principal a assistência.

Entre os novos conceitos introduzidos pela norma, ressaltam-se os relativos à gestão e à gerência. Assumir a gestão significa apropriar-se do comando do sistema, o que é de exclusiva competência do Poder Público.

Importante: "São [...] gestores do SUS os Secretários Municipais e Estaduais de Saúde e o Ministro da Saúde, que representam, respectivamente, os governos municipais, estaduais e federal" (BRASIL, 1996).

No que se refere à gerência, assumi-la significa responsabilizar-se pela administração, ou seja, dirigir uma unidade ou órgão prestador de serviços de saúde – ambatório, hospital, instituto, fundação etc.

– Que presta serviços ao sistema. Dessa forma, a gerência de estabelecimentos prestadores de serviços pode ser estatal ou privada, esta última desde que conveniada ou contratada por um gestor do SUS (BRASIL, 1996).



RESUMINDO

Nesta unidade vimos que a busca permanente por mais saúde e pela superação dos riscos e dos agravos debilita a vida e torna-se objeto das sociedades e dos estados. Essa condição propicia que a saúde seja considerada como decorrente de formas integradas nos arranjos societários, de modo que, em todos os seus setores e ambientes, a saúde seja um objetivo. Essa possibilidade acontecerá de fato quando a sociedade, seus indivíduos, grupos políticos, organizações em geral e seus aparatos reguladores – o Estado e as suas normas – materializarem tal status à saúde. Não há um modelo certo ou errado, e sim modelos que se moldaram em determinados momentos e em determinadas sociedades concretas. Os modelos assistenciais, porque são construções históricas, sofrem condicionamentos econômicos, sociais, tecnológicos, cognitivos, culturais e das épocas em que se desenvolvem. Esses condicionamentos podem ser agrupados em duas dimensões: a socioeconômica e a científico-cultural.

Na primeira, situam-se os condicionantes relacionados à vida e à maneira como uma dada sociedade encara e define a saúde, seja no plano do conhecimento, seja no plano da cultura e das representações sociais.

Os modelos de atenção adotados em diversas sociedades vêm acompanhando historicamente a sua própria evolução e os avanços na medicina. Desde a medicina mágica da antiguidade clássica, passando pela era medieval até a medicina moderna, fundada na anatomoclínica e na revolução microbiológica, a evolução dos saberes entrelaça-se com a evolução das sociedades, das crenças e dos interesses dos diversos grupos sociais. É importante lembrar que o Estado aparece como o espaço de definição do interesse público e das ações coletivas.

O tratamento dado à saúde pública sofreu todas as influências e foi marcada por sucessivas visões: a ênfase dos gregos e romanos antigos nas questões de água e saneamento; a ênfase medieval das epidemias e nos mecanismos de transmissão; a ênfase do ilusionismo na prevalência das doenças; a ênfase do período industrializante nas condições de trabalho; e a ênfase da era moderna na bacteriologia e na virologia.

Examinamos a maneira como evoluíram as diversas concepções a respeito do processo saúde-doença, e também o processo por meio do qual a saúde se constitui como objeto das políticas públicas, e os diversos documentos criados a respeito de cada ciclo de vida adquirindo status de problema individual, mas também garantindo esta saúde como direito social.

São, portanto, todos os elementos históricos e que, certamente, continuam a moldar, já renovados, superados ou simplesmente enriquecidos, o futuro das práticas em saúde. Futuro no qual, agora, interferimos.

Aprendemos que é preciso construir outro conhecimento: o de que os modelos não existem em estado puro, ou seja, não se constituem exatamente como são descritos na literatura especializada. No plano das sociedades concretas, convivem diversos modelos, ou diversas lógicas de organização da atenção, embora sempre haja uma hegemonia, que é então o paradigma que caracteriza

aquela época e aquela sociedade. O Brasil é um caso ilustrativo dessa combinação de lógicas assistenciais distintas e até mesmo contraditórias. Isso se dá porque quanto mais complexa e diversificada é uma sociedade, maior é a diversidade de situações de saúde, e, portanto, maiores são as probabilidades de conviverem estratégias distintas de intervenção, cuja lógica dominante é definida pela hierarquia. Esse esclarecimento é importante para que não nos esqueçamos de que os processos de mudança de modelos, mais do que uma fórmula, exigem uma nova combinação de modalidades de práticas.

Assim, os modelos são construções sociais, ou seja, correspondem a um processo dinâmico de disputas e de acordos entre os diversos segmentos sociais que confrontam seus interesses, suas crenças e seus valores nas arenas sociais e nas de formulação de políticas. Não há nenhum modelo assistencial isento de interesses ou acima das vontades dos diversos grupos, eles condensam os acordos possíveis entre as distintas visões e os interesses dos distintos grupos. Por isso, uma mudança de modelo, envolve também uma dimensão de luta política, na medida em que representa um novo equilíbrio de interesses e valores.

Atualmente, cada vez mais, considera-se que não há modelos gerais ou universais, e sim modelos de atenção específicos para cada problema ou grupo de problemas de saúde, já que o grau de conhecimento científico, assim como o grau de importância que cada sociedade dá a este ou aquele agravo, não é constante ou equivalente. A busca de efetividade exige a diversificação de estratégias e ações, assim como diferentes combinações de recursos e padrões de organização do trabalho.

Nessa unidade também vimos que o SUS, hoje, representa inequivocamente o sistema mais avançado entre os que já tiveram vigência no Brasil. Sua importância num país com a desigualdade e as carências do nosso é pouco questionada atualmente. Tanto que, apesar das restrições ao seu desenho universalista e mesmo considerando suas óbvias imperfeições, não parece haver hoje nenhum segmento disposto a propor a sua extinção ou substituição por outro sistema, de caráter segmentado ou excludente.

Por isso, vale a pena um rápido balanço, tomando como referência as três dimensões do SUS, tais como já propostas nesse texto, a título de ensaiar uma agenda de temas desafiantes para os próximos anos.

Como novo pacto social, voltado para garantir o acesso universal e igualitário a todos os cidadãos, o SUS certamente tem ainda uma longa trajetória a cumprir. Embora tenha um caráter claramente redistributivo, na medida em que acolhe amplos segmentos populacionais antes excluídos, a partir de recursos do conjunto da sociedade, tais recursos são ainda insuficientes num contexto econômico geral que reproduz a desigualdade.

Assim, pudemos compreender que o principal obstáculo ao seu desenvolvimento como pacto solidário situa-se na questão do financiamento, que é a área em que finalmente a sociedade concretiza seu padrão de solidariedade. De um lado, a questão do volume de recursos destinados à saúde, hoje claramente abaixo do mínimo necessário. De outro, a questão da divisão de responsabilidades no seu provimento, seja entre as esferas governamentais, seja entre o Estado e os diversos segmentos sociais.

Também deve ser assinalado o desafio de regular e estabelecer relações com o setor privado suplementar que, nos últimos anos, experimentou crescimento exponencial, sendo hoje responsável pela cobertura de cerca de um quarto da população brasileira. Os esforços recentes em direção à sua regulamentação podem abrir novos horizontes para uma redefinição de papéis no pacto nacional de saúde.

Estudamos que, com o novo desenho político-institucional, o SUS certamente representa uma experiência latamente inovadora, indicativa do quanto a descentralização e a participação podem contribuir para um melhor desempenho da gestão pública. O desenho das parcerias envolvidas na cultura da gestão descentralizada e pactuada pode servir de modelagem para outras áreas de políticas públicas, seja no interior do Estado, entre as esferas, sugerindo um padrão inovador de pacto federativo, seja entre o Estado e a sociedade, compartilhando responsabilidades e decisões.

É evidente que há muito que caminhar em direção a mecanismos mais ágeis e efetivos de, a partir de transformações no Estado e na sociedade, gerar maiores graus de accountability, retroalimentando a responsabilidade pública. De qualquer forma, a experiência da saúde e do SUS tem o significado de desenhar uma proposta ou agenda de reforma no Estado que prescreva não a sua redução, mas o seu melhor desempenho público, ou seja, sua maior capacidade de expressar e de exercer o interesse público.

Devemos lembrar também que as limitações no financiamento podem ter um efeito dramático nesse contexto, caso os ganhos em cobertura da atenção básica, alcançando populações até então excluídas, não sejam acompanhados de ganhos em resolutividade e qualidade da atenção. Teríamos, então, não um modelo da atenção integral, mas um modelo perverso em que as populações marginais teriam acesso parcial e subalterno ao sistema, sem nenhuma chance de resolver problemas mais complexos. O sistema se eximiria da atenção de média e alta complexidade, deixando-a a cargo do mercado, na qual estaria acessível apenas aos setores que pudessem comprá-la.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, L. G.; FRANÇA, A. C. L. Estratégias de Recursos Humanos e Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho: o stress e a expansão do conceito de qualidade total. Revista de Administração, São Paulo, v. 33, nº 2, p. 40 51, abr./jun. 1998. Disponível em: . Acesso em: 8 dez. 2014.

BALLONE, G. J.; MOURA, E. C. Estresse e trabalho: como o trabalho pode favorecer o estresse. PsiquWeb, 2008. Disponível em: . Acesso em: 13 jan. 2014.

BARBOSA, P. R. (Coord.). Curso de especialização em autogestão em saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2001.

BATISTA, C. B. et al. Violência no trabalho em saúde: análise em unidades básicas de saúde de Belo Horizonte, Minas Gerais. Trab. Educ. saúde (online), Rio de Janeiro, v. 9, n. 2, jul./out. 2011. Disponível em: . Acesso em: 8 dez. 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização. [s.d.]. Disponível em: . Acesso em: 24 nov. 2014.

____. Lei nº 6.229, de 17 de julho de 1975. Dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Saúde. Brasília: Diário Oficial da União, 1975. Revogada pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponível em: . Acesso em: 13 nov. 2014

Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 1990a. Disponível em: . Acesso em: 12 nov. 2014.

MOTTA, P. R. Gestão contemporânea: a ciência e a arte de ser dirigente. Rio de Janeiro: Record, 1991.

NOLETO, M. J. Abrindo espaços: educação e cultura para a paz. 4. ed. rev. Brasília: Unesco; Fundação Vale, 2008. Disponível em: . Acesso em: 12 jan. 2014.

OLIVEIRA, I. Z. A qualidade de vida no trabalho e o processo de humanização: um estudo na empresa AB&C moda infantil em Santa Cruz do Capibaribe PE. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso – Administração de Empresas. FAVIP, Caruaru, 2011.

OLIVEIRA, R. P.; NUNES, M. O. Violência relacionada ao trabalho: uma proposta conceitual. Saúde Soc., São Paulo, v. 17, n. 4, p. 22 34, 2008.

PASCHE, D. F.; PASSOS, E. A importância da humanização a partir do Sistema Único de Saúde. Rev. Saúde Públ., Florianópolis, v. 1, n. 1, jan./jun. 2008. _____. Apresentação: cadernos temáticos PNH: formação em humanização. In: BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos HumanizaSUS. Volume 1: formação e intervenção. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. (Série B. Textos Básicos de Saúde). Disponível em: . Acesso em: 21 nov. 2014. PEREIRA, A. D. et al. Atentando para as singularidades humanas na atenção à saúde por meio do diálogo e acolhimento. Rev. Gaúcha Enferm. (online), Porto Alegre, v. 31, n. 1, mar. 2010. Disponível em: . Acesso em: 8 dez. 2014. PEREIRA, F. M. A Inserção do psicólogo no hospital geral: a construção de uma nova especialidade. Dissertação (Mestrado em História das Ciências da Saúde) – Casa de Oswaldo Cruz, FIOCRUZ, Rio de Janeiro, 2003. Disponível em: . Acesso em: 9 jan. 2015.

Logística Hospitalar

Edmundo Souza



TeleSapiens